

Una persona autistica ad alto supporto in vostra cura

Per medici di famiglia, medici di RSA e clinici — nella cura di un adulto autistico in **assistenza residenziale / ad alto supporto** (qualsiasi età).

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione si blocca in pochi „tunnel” profondi e intensi. Per una persona autistica ad alto supporto, gli ambienti di cura sono spesso i **più difficili in assoluto**: ostili sensorialmente, rompono le routine, pieni di tocco e richieste imprevedibili. Molti comunicano senza parole (CAA, comportamento o una persona di fiducia) e possono non registrare o riferire dolore finché non è grave. Consenso, capacità e dignità dipendono dal lavorare *con* l'attenzione della persona, le sue routine e le persone di fiducia — mai dando per scontata l'incapacità da una comunicazione atipica.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
Angoscia, autolesionismo, „comportamento problematico”, rifiuto	Nella stragrande maggioranza comunicazione di un bisogno non soddisfatto — dolore, paura, sovraccarico sensoriale, routine persa
Meltdown o shutdown durante le cure	Risposta involontaria del sistema nervoso al sovraccarico — <i>non</i> aggressione o mancata osservanza
Non riferisce dolore; collasso improvviso / presentazione tardiva	Differenze di interocezione — i segnali interni possono non registrarsi finché non sono gravi
Ritiro quando cambiano oggetti, ordine o personale	Le routine e le cose sono ancore di identità e sicurezza
Nessun linguaggio affidabile; si affida a CAA, comportamento o un accompagnatore	Comunicazione atipica ≠ mancanza di capacità o comprensione

Provate questo

- **Costruite la cura attorno alla prevedibilità**: personale coerente, stessa sequenza, orari visivi, preavviso di ogni cambiamento.
- **Abbassate il carico sensoriale** — stanza silenziosa, luce bassa, riducete bip e odori forti; preservate gli oggetti, gli interessi e le routine della persona.
- **Investigate il dolore e le cause fisiche per primi** per ogni nuova angoscia o cambiamento di comportamento — stipsi, dolore dentale, infezione, attrezzatura mal adattata sono colpevoli comuni e nascosti.
- **Usate la presa di decisione supportata**: spiegate in forma accessibile e letterale; concedete tempo di elaborazione; consultate l'accompagnatore di fiducia e qualsiasi profilo comunicativo/anticipato.
- **Avere un piano scritto e calmo per meltdown/shutdown**: riducete la stimolazione, assicurate la sicurezza, date tempo e spazio — non contenete né punite.

Evitate questo

- Etichettare l'angoscia come „comportamentale” prima di aver escluso dolore e sovraccarico.
- Usare contenimento o sedazione come prima risposta a meltdown/shutdown.
- Rimuovere routine, oggetti o interessi „per il suo bene”, o dare per scontata l'incapacità da una comunicazione atipica.

Quando serve altro supporto

Trattate l'**angoscia nuova o crescente** come un segnale d'allarme medico finché non sono esclusi dolore, infezione, stipsi, problemi dentali e cause sensoriali/ambientali. Screenate il **burnout autistico** sotto carico cronico. Coinvolgete **équipe specialistiche autismo / disabilità intellettiva e logopedia (CAA)**. Documentate un profilo **sensoriale, comunicativo e di adeguamenti ragionevoli** individualizzato e incorporatelo nel piano di cura.

Nota di genere

Le donne ad alto supporto sono particolarmente sotto-identificate e mal servite; la loro angoscia è ancora più spesso letta male. Applicate lo stesso rigore nell'escludere dolore e sovraccarico a prescindere dalla presentazione o dal metodo di comunicazione.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la sintesi sul **Monotropismo** e la guida **Lifespan per professionisti e sanitari** (Parti 3.5 e 4) più la guida per la **famiglia** (Parte 5, case di cura e ospedali). Usa il linguaggio con l'identità per prima.

Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico. Adattatela al/dalla singolo/a.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024, interocezione/dolore); AASPIRE AHAT; Autism Society (2025, meltdown/shutdown); Leicestershire Partnership NHS Trust (Autism Space). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.